



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متكرر

إسم المريض ربيعاً : سناء رياض محمد ابوزينه

المحافظة : الجيزة الحي / المدينة : العياط

العنوان : قرية القطوري - مركز العياط - الجيزة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 03-10-2026

رقم البطاقة : 26010072102065 رقم التليفون : 01111118722

العمر (تاريخ الميلاد) : 07-10-1960 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك الإحصائي الاجتماعي

المقر بما فيه التوقيع: (-----) التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام ماموجرام وسونار علي الثديين [10888] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : ----- التوقيع : -----

الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : ----- التوقيع : -----

الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : ----- التوقيع : -----

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / د. / أ.د. / د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----

خطة العلاج : -----

المستشفى : -----

قسم : -----

جهة العلاج : -----

نفقات : -----

ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: سناء رياض محمد ابوزينه National ID: 26010072102065	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Bilateral mammogram and breast ultrasound
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



سواء
رياض محمد ابوزينه
قرية القطوري
مركز العياط - الجيزة

١٩٦٠/١/١٧ ٢٦٠١٠٠٧٢١٠٢٠٦٥

II8796181

MS
نه نسي
مقاييه



٢٠٢٠/٠٢ ٢٦٠١٠٠٧٢١٠٢٠٦٥

بدون عمل

أرملة

مسلمة

أنثى



البطاقة سارية حتى ٢٠٢٧/٠٢/٢٤

١





رسوم الاستعلام 20 جنية

جهاز الاصدار : فرع الجيزة

تاريخ الاصدار : 2026-7-6

الى من يهمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانتماء الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 " الاطفال دون السن المدرسى " وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .
وطبقا لقاعدة البيانات المرسله من التأمينات الاجتماعيه
وطبقا لقاعدة البيانات المرسله من الضمان الاجتماعى

والبحث تبين أن

السيد (ة) سناء رياض محمد بطاقة رقم 26010072102065

تليفون رقم: لا يوجد

وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل

وشكرا

تاريخ الطباعة : 2026-7-6

الموظف المختص

كريمة ابراهيم



يعتمد،،،

مسلسل 2014951



الخطاب سارى لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ الاصدار الا فى حاله تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية او وزارة التضامن الاجتماعى او وزارة التربية و التعليم

الادارة المركزية للنظم المعلومات و التحول الرقمى

PATHOLOGY DEPARTMENT
HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: سناء رياض محمد ابوزينه

Age: 66 years

Sex: female

Request type: مبادره

Sub request type:

Hospital no:

Pathology no.: 611-2026

Department: صحة مرآه

Date of result: 21/7/2026

Referred by: د/مروه حسن

Date of biopsy: 12/7/2026

Nature of specimen: tru-cut biopsy

I.D. Number: 26010072102065

Clinical diagnosis: Right breast mass

Gross pathology :

Multiple grayish white tissue cores up to 1cm long, totally submitted.

Immunohistochemical Technique:

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against: ER- PR- Her2- Ki67

Microscopic picture: Section examined revealed core of tumor showing invasive duct carcinoma of no special type (NST). The tumor forms nests, tubule and cribriform pattern infiltrating among desmoplastic stroma with moderate lymphocytic infiltration. Tumor cells showing moderate anaplasia and moderate tendency to form tubules. There is moderate number of mitotic figures. Foci of calcifications were seen. No carcinoma in situ component detected.Immunohistochemical Result:

ER: Moderate nuclear staining in 20% of tumor cells (Allred Score 5/8).

PR: Moderate nuclear staining of 15% of tumor cells (Allred Score 5/8).

Her2: Strong complete membranous staining in >10% of tumor cells (score 3+).

Ki67: Positive nuclear staining of 40% of tumor cells.

Diagnosis: Right breast mass, tru cut biopsy:

Invasive Duct Carcinoma, (NST) Grade II.

Signature:

Dr. Nermine Nabil.M.D

Dr. 29/7/2026

Pathology Lab. Manager

BASMA REFAAT M.D

Patient ID: 96788	Patient Name English: Sanaa Riad Mohamed
Age: ٦٥ سنة ٨ شهر	2026/06/30 10:54:34 AM : Report Date

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary: 65 years old female patient with right breast lump.

Detailed Findings

Right breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- The right breast shows central large ill-defined spiculated dense mass lesion
- Ultrasound revealed ill defined hypoechoic mass lesion measures about 17x15mm at its maximum diameters and located at 11-12 ° clock position. With internal calcifications
- A dilated duct seen with internal contents and calcifications reaching to nipple
- Normal nipple/areolar complex.
- 2 enlarged axillary lymph nodes at level I, with effaced hila, largest one measures about 22 x 14 mm at with cortical thickness of 12mm level I.

Left breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- Ultrasound demonstrated prominent glandular elements of the breast tissue with mottled appearance.
- Multiple small dispersed subcentimetric thin-walled anechoic cysts.
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- Right breast (BIRADS 5): Right malignant mass lesion with ipsilateral pathological axillary lymph nodes as described , suspicious microcalcifications and intraductal extension . For tru cut biopsy.
- Left breast (BIRADS 1): normal study .

*Much obliged,
Dr. marwa a. el seoud*

9/27/26, 1:28 PM

MDT Form

code:09 -- Name_A MDT FORM -- Name_E MDT FORM

جوسناتو
روني
١٨C46
9-27مبادرة رئيس الجمهورية
لدم صحة المرأة المصريةمبادرة
صحة
المرأة
مصر

09/27/2026

MDT FORM

Name:	ملاء رباب محمد ابو زيد	MRN:	13056
Age:	66 Y	ID:	26010072102065
Menopausal Sta	POST MENOPASUAL	Phone:*	01154391250
NRS SCORE:		Marital Status:	WIDOW
BMI:		Family History:	FREE
Gender		Reason Of MDT:	
CO Morbidity:	HTN	NEW	
Surgical History:*	FREE	ECOG Performance Status	☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Clinical Data:

BX: INVASIVE DUCTAL CARCINOMA

ER: 5/8 PR: 5/8 HER2: 3+ KI67: 40%

History:

ACR B

ILL DEFINED HYPOECHOIC MASS 11 TO 12 O'CLOCK
DILATED DUCTS REACHING NIPPLE

2 ENLARGED AXILLARY LYMPH NODES

Sonomammography:

Biomarker/Molecular

Mets Workup:

BONE SCAN FREE

CAP FREE

Recommendations:

FOR CLIP INSERTION

AFTER ASSESSMENT OF DILATED DUCTS BY U/S

NACT

THEN BCS+SLNB ACCORDINGLY

MDT Outcome & Plan

CESM(INITIAL)

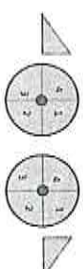
PORTA CATH /ECHO

TCHP X 6 C

THEN SURGERY ACCORDING TO CESM RESULT

R

L



TNM

Right Side
Q1 Q2 Q3 Q4Left Side
Q1 Q2 Q3 Q4

Clinical Staging:

CT2 N1

Pathological Staging:

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
د محمد كواشي	د محمد خير لوي	د نورهان رمضان	

about:blank